BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ TRUNG
TỔ THÔNG TIN THUỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Trung, ngày 20 tháng 5 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC
AT Famotidine 40 inj

THÀNH PHẦN: Mỗi lọ 5 ml dung dịch tiêm chứa:
Hoạt chất: Famotidine…….40 mg
Tá dược: Vừa đủ.
(L-Aspartic acid, Mannitol, Benzyl alcohol, Sodium hydroxide, Nước cất pha tiêm).
DẠNG BÀO CHẾ: Dung dịch tiêm.
Mô tả sản phẩm: Dung dịch trong, không màu hoặc màu vàng nhạt.

CHỈ ĐỊNH

Loét dạ dày hoạt động lành tính, loét tá tràng hoạt động.
Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản.
Bệnh lý tăng tiết đường tiêu hóa (ví dụ: Hội chứng Zollinger - Ellison, đa u tuyến nội tiết).

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng

Loét dạ dày thường do vi khuẩn Helicobacter pylori. Tình trạng loét dạ dày, tá tràng có thể cải thiện sau khi trừ tiệt vi khuẩn này. Các thuốc chống tiết acid phối hợp với kháng sinh đạt được hiệu quả điều trị cao.
Ở người bệnh tăng tiết dịch vị bệnh lý hoặc loét dai dẳng hay người không uống được:
Dùng famotidine tiêm với liều 20 mg, cứ 12 giờ một lần, điều chỉnh theo đáp ứng của bệnh nhân, cho tới khi uống được.
Đối với người cao tuổi và trẻ em:
Độ an toàn và hiệu quả của thuốc đối với trẻ em chưa được xác định.
Liều dùng không cần thay đổi theo tuổi, chỉ điều chỉnh ở người bệnh suy thận nếu cần.

Cách dùng

Famotidine dùng tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch chậm ở bệnh viện cho người bệnh quá tăng tiết acid hoặc loét tá tràng dai dẳng hoặc người không uống được. Có thể phối hợp với thuốc chống acid để giảm đau nếu cần.
Tiêm tĩnh mạch: Tiêm tĩnh mạch chậm, ít nhất là 2 phút.
Tiêm truyền tĩnh mạch: Famotidine đã pha sẵn (bình chứa 20 mg famotidine trong 50 ml natri clorid 0,9%) truyền trong thời gian từ 15 đến 30 phút.
Pha loãng 1/2 lọ famotidine (20 mg/2,5 ml) với 50 ml natri clorid 0,9% hoặc các dung dịch tiêm tương hợp với famotidine và tiêm truyền tĩnh mạch chậm trong thời gian từ 15 đến 30 phút.

Dung dịch tiêm famotidine có thể pha loãng trong nước cất pha tiêm, natri clorid 0,9%, glucose 5% hoặc 10%, Ringer lactat, natri hydrocarbonat 5%. Dung dịch tiêm famotidine sau khi pha loãng chứa khoảng 0,2 - 4 mg/ml, bền vững trong 48 giờ ở nhiệt độ phòng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người có tiền sử dị ứng với thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Đáp ứng triệu chứng với famotidine không loại trừ được tính chất ác tính của loét dạ dày.

Famotidine nên dùng thận trọng ở người suy thận (nghĩa là độ thanh thải creatinine dưới 10 ml/phút) do thuốc thải trừ chủ yếu qua thận. Cần giảm liều hoặc tăng khoảng cách giữa các liều dùng. Tuy vậy, nhà sản xuất cho rằng tác dụng không mong muốn không liên quan đến nồng độ cao đo được trong huyết tương của người suy thận.

Sử dụng thận trọng do thuốc làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Cảnh báo tá dược

Thành phần thuốc có chứa 45 mg benzyl alcohol trong mỗi lọ 5 ml, hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ khi bệnh nhân mắc bệnh gan, thận hoặc bệnh nhân là phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, bởi vì dùng lượng lớn benzyl alcohol có thể gây tích lũy trong cơ thể và gây ra các tác dụng không mong muốn (gọi là toan chuyển hóa). Ngoài ra, benzyl alcohol còn có thể gây các phản ứng dị ứng.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai

Nghiên cứu ở động vật cho thấy thuốc không có hại đến thai, nhưng không phải luôn luôn tương tự như ở người. Thuốc chỉ được dùng cho người mang thai khi thật cần thiết.

Phụ nữ cho con bú

Famotidine có bài tiết qua sữa mẹ. Người mẹ nên ngừng cho con bú trong thời kỳ dùng thuốc hoặc ngừng dùng thuốc.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không gây ảnh hưởng đến khả năng lái tàu xe, vận hành máy móc nhưng do có thể gây ra tác dụng không mong muốn như chóng mặt, buồn ngủ nên tốt nhất không dùng famotidine khi đang tham gia các hoạt động này.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỴ CỦA THUỐC

Tương tác thuốc

Tác động đến sự chuyển hóa thuốc ở gan:

Khác với cimetidine và ranitidine, famotidine không ức chế sự chuyển hóa bằng hệ enzyme gan cytochrome P450 của thuốc bao gồm warfarin, theophylline, phenytoin, diazepam và procainamide. Famotidine cũng không tác động đến sự chuyển hóa, độ thanh thái và thời gian bán thái của aminophenazone hay phenazone. Tuy nhiên thuốc cũng có tác động rất ít đến enzyme cytochrome P450 và cần phải có thêm kinh nghiệm dùng thuốc lâu dài và với liều tương đối cao để xác định tiềm năng nếu có, tác dụng quan trọng về lâm sàng. Famotidine không ảnh hưởng đến bài tiết của indocyanin xanh lục.

Tương kỵ
Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC (ADR)
Thường gặp (1/100 ≤ ADR < 1/10):
- Toàn thân: Nhức đầu, chóng mặt.
- Tiêu hóa: Táo bón, tiêu chảy.
Ít gặp (1/1.000 ≤ ADR < 1/100):
- Toàn thân: Sốt, mệt mỏi, suy nhược.
- Tim mạch: Loạn nhịp.
- Tiêu hóa: Vàng da ứ mật, enzyme gan bất thường. buồn nôn, nôn, chán ăn, khó chịu ở bụng, khô miệng.
- Phản ứng quá mẫn: Choáng phản vệ, phù mạch. phù mắt, phù mặt, mày đay, phát ban, sung huyết kết mạc.
- Cơ xương: Đau cơ xương, gồm chuột rút, đau khớp.
- Thần kinh: Co giật toàn thân, rối loạn tâm thần như: Ảo giác, lú lẫn, kích động, trầm cảm lo âu, suy giảm tình dục, dị cảm, mất ngủ, ngủ gà.
- Hô hấp: Co thắt phế quản.
- Giác quan: Mất vị giác, ù tai.
Hiếm gặp (1/10.000 ≤ ADR < 1/1.000):
- Tim mạch: Block nhĩ, đánh trống ngực.
- Máu: Giảm bạch cầu hạt, giảm huyết cầu toàn thể, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu.
- Da và mô dưới da: Hoại tử da nhiễm độc, rụng tóc, trứng cá, ngứa, khô da, đỏ ửng.
- Tác dụng khác: Liệt dương, vú to ở đàn ông.
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ :
Quá liều
Chưa gặp quá liều cấp.
Ở người bệnh tăng tiết dịch vị bệnh lý đã uống tới 800 mg famotidine/ngày cũng chưa thấy xảy ra các biểu hiện ngộ độc nặng.
Cách xử trí
Điều trị**:** Điều trị triệu chứng và hỗ trợ cần tiến hành ngay.
Giám sát lâm sàng.
CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ
Nhóm dược lý: Đối kháng thụ thể histamine H2
Mã ATC: A02BA03
Famotidine ức chế cạnh tranh tác dụng của histamine ở thụ thể H2 tế bào vách, làm giảm tiết, giảm nồng độ acid dạ dày cả ngày và đêm, cả khi bị kích thích do thức ăn, histamine hoặc pentagastrin. Hoạt tính đối kháng histamine ở thụ thể H2 của famotidine phục hồi chậm, do thuốc tách chậm khỏi thụ thể. So sánh theo phân tử lượng famotidine có hoạt lực mạnh hơn gấp 20 – 160 lần so với cimetidine và 3 - 20 lần so với ranitidine trong ức chế tiết acid dạ dày. Sau khi tiêm tĩnh mạch, tác dụng tối đa đạt trong vòng 30 phút. Liều tĩnh mạch duy nhất 10 và 20

mg ức chế tiết ban đêm trong thời gian 10 đến 12 giờ. Liều 20 mg có tác dụng lâu nhất ở phần lớn người. bệnh. Liều duy nhất uống buổi tối 20 và 40 mg ức chế tiết acid cơ bản vào ban đêm ở mọi người bệnh.

Dược động học

Famotidine chuyển hóa ít ở pha đầu. Famotidine liên kết với protein huyết tương. Thời gian bán thải: 2,5 - 3,5 giờ. Thải trừ qua thận 65 - 70% và qua đường chuyển hóa 30 - 35%. Độ thanh thải ở thận là 250 - 450 ml/phút, chứng tỏ bài tiết một phần ở ống thận. 65 - 70% liều tiêm tĩnh mạch có trong nước tiểu dưới dạng không biến đổi. Chất chuyển hóa duy nhất xác định được ở người là S - oxid. Có mối liên quan chặt chẽ giữa độ thanh thải creatinine và thời gian bán thải của famotidine. Ở người suy thận nặng, độ thanh thải creatinine dưới 10 ml/phút, thì thời gian bán thải có thể hơn 20 giờ, vì vậy cần điều chỉnh liều hoặc khoảng cách giữa các liều dùng.

Điều trị duy trì ở liều thấp các thuốc kháng histamin H2 làm giảm tỉ lệ loét tái phát, nhưng không làm thay đổi quá trình diễn biến của bệnh khi ngừng thuốc và phải xét đến điều trị triệt căn H. pylori. Điều trị duy trì là thích hợp nhất cho những trường hợp thường xuyên tái phát nặng và cho những người cao tuổi bị biến chứng loét.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 1 lọ, 3 lọ, 5 lọ × 5 ml.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

AN THIEN PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN

314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Sản xuất tại nhà máy:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN

Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước. Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin cần cung cấp thêm xin chủ động liên hệ bộ phận

Dược lâm sàng Thông tin thuốc

TỔ THÔNG TIN THUỐC